

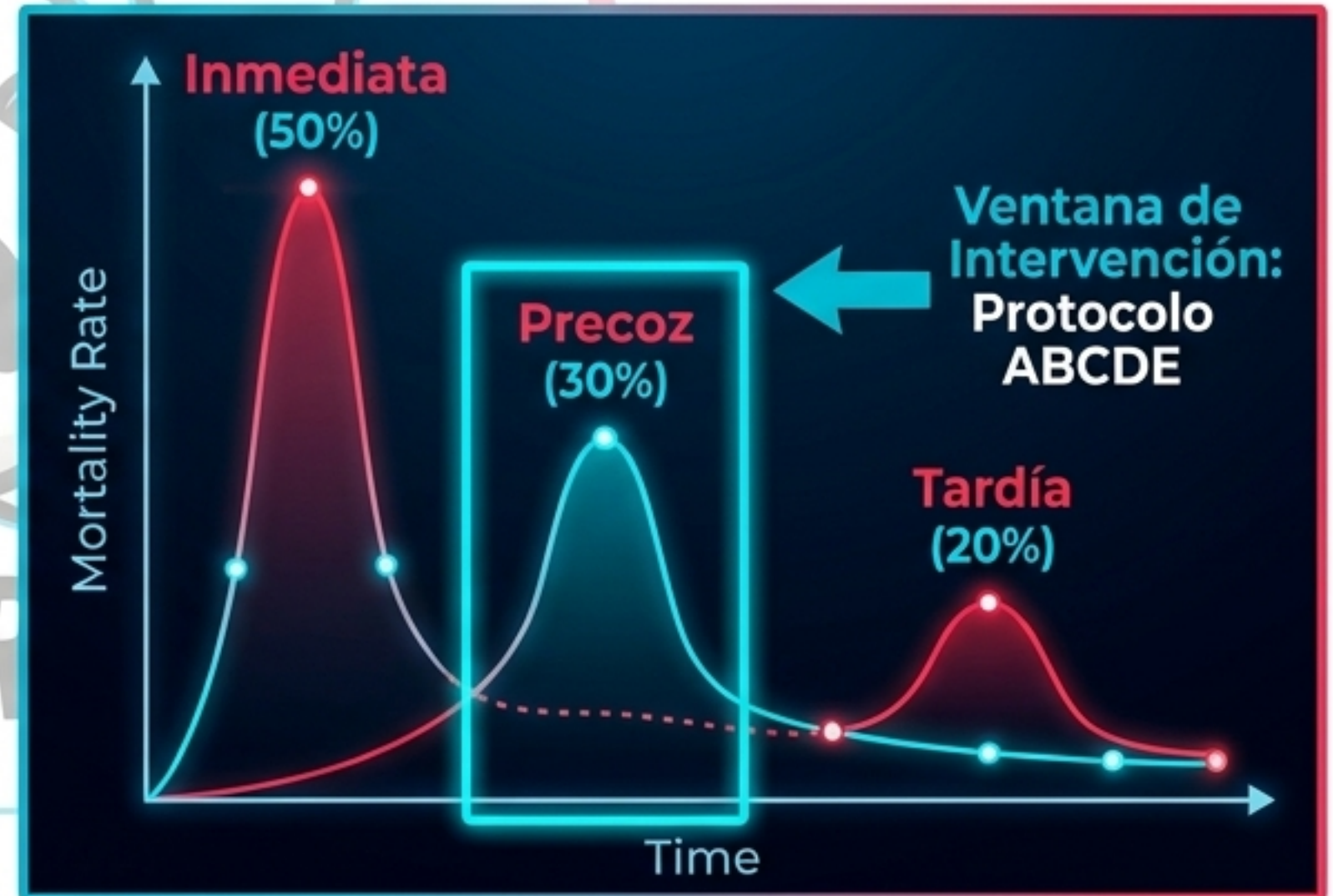
Manejo Integral del Paciente Politraumatizado y Traumatismo Abdominal

Guía Clínica Definitiva de Supervivencia y Reanimación

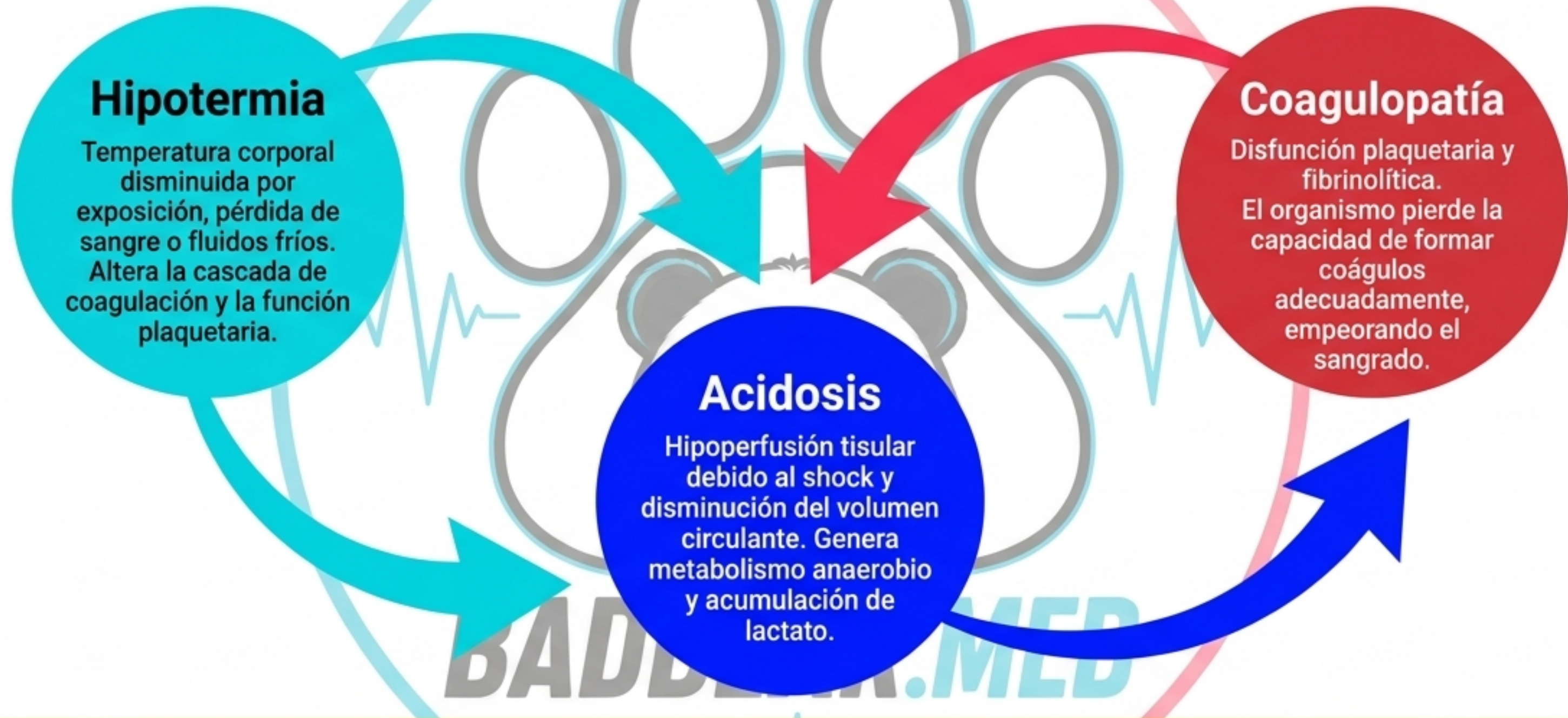
Distribución Trimodal de la Mortalidad

Politrauma: Paciente con dos o más lesiones traumáticas graves (vascular, musculoesquelética o visceral) que conllevan riesgo inminente de muerte o invalidez.

La Hora Dorada: Periodo crítico post-trauma donde la resucitación e intervención oportuna previenen la mortalidad evitable.



La Tríada Mortal del Trauma: El Círculo Vicioso



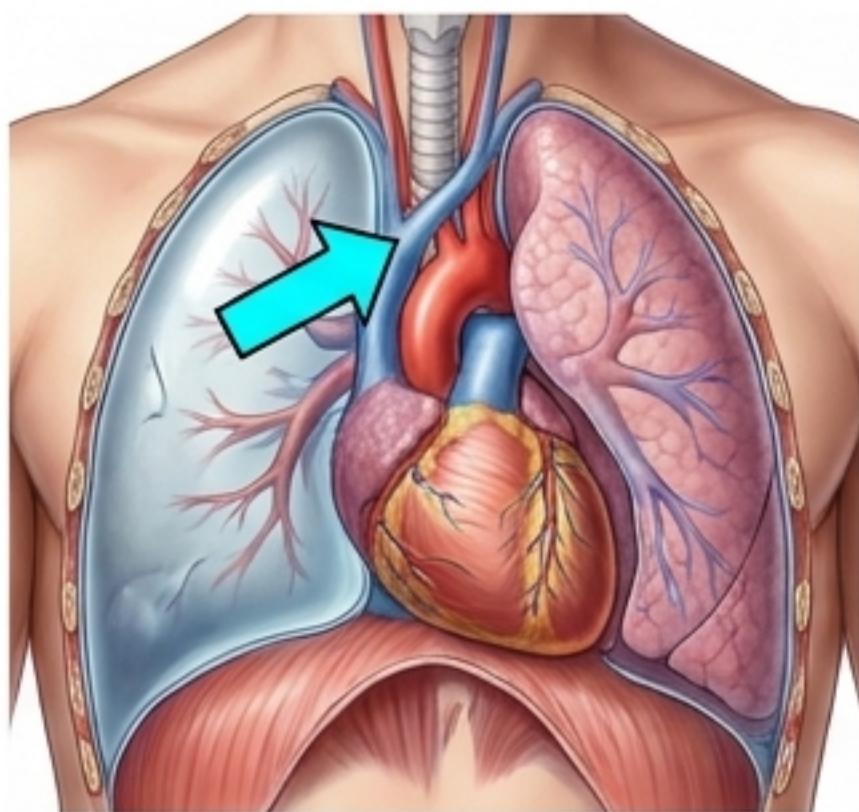
¡El Objetivo Principal! Romper este ciclo controlando la hemorragia, calentando al paciente y restaurando la perfusión antes de que sea irreversible.

Evaluación Primaria: Protocolo Dinámico X-A-B-C-D-E

Paso	Evaluación	Intervención Inmediata
X Exanguinación	Hemorragia externa masiva.	Compresión directa, empaquetamiento, torniquete en extremidades. ¡La X va primero!
A Vía Aérea	Permeabilidad y control cervical.	Tracción mandibular / elevación del mentón (evitar hiperextensión). Intubación endotraqueal si Glasgow < 8.
B Ventilación	Frecuencia, expansión, murmullo vesicular.	Oxigenoterapia, identificar neumotórax/hemotórax.
C Circulación	Pulsos, color de piel, llenado capilar, presión arterial.	Controlar sangrado interno, accesos venosos, prevenir shock.
D Déficit Neurológico	Escala de Glasgow, pupilas (reactividad/tamaño).	Prevenir lesión cerebral secundaria (oxigenación/perfusión).
E Exposición	Búsqueda de lesiones ocultas.	Corte de ropa, rotación en bloque, control térmico estricto (mantas térmicas).



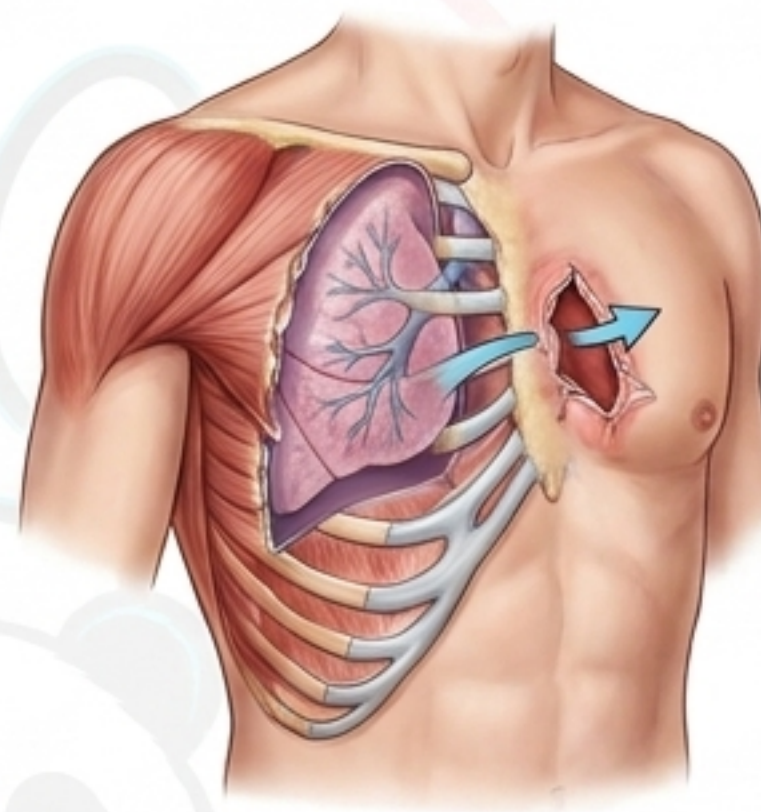
Lesiones Inminentes Mortales (Tórax y Corazón)



Neumotórax a Tensión

Signos: Hipotensión, ausencia de murmullo, desviación traqueal, ingurgitación yugular.

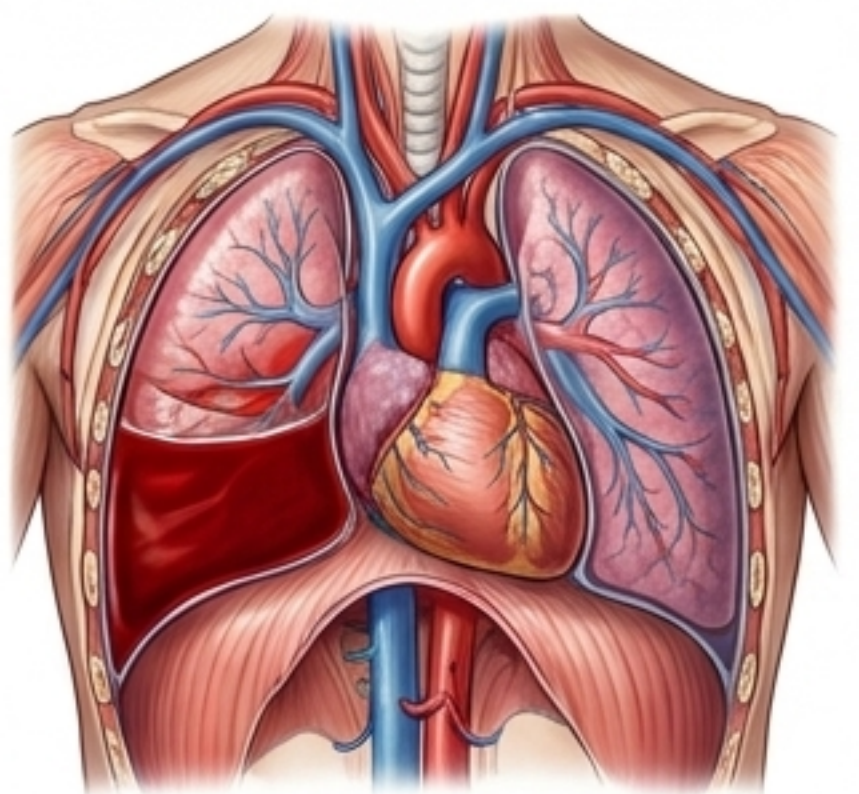
Tratamiento: Descompresión inmediata con aguja o toracostomía.



Neumotórax Abierto

Signos: Pared torácica con soplo audible, defecto abierto.

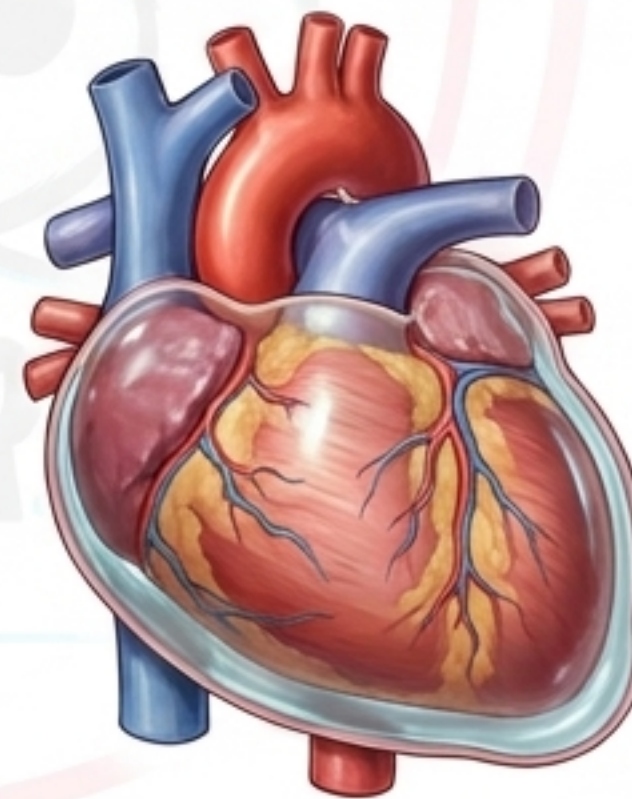
Tratamiento: Parche oclusivo con sellado de 3 bordes (válvula unidireccional) + tubo de tórax.



Hemotórax Masivo

Signos: Matidez a la percusión, colapso circulatorio, shock profundo.

Tratamiento: Tubo endotorácico de gran calibre + transfusión de hemoderivados.



Taponamiento Cardíaco (Tríada de Beck)

Signos: Hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos velados.

Tratamiento: Pericardiocentesis guiada por ecografía o toracotomía de rescate.

Shock Hemorrágico: Los 5 Focos Ocultos

Regla Clínica: En un paciente politraumatizado con shock, se asume hemorragia hasta demostrar lo contrario. (Presión arterial aparentemente normal no descarta hemorragia significativa).

Signos Tempranos

Taquicardia, piel fría/pálida/sudorosa, llenado capilar prolongado >2s.

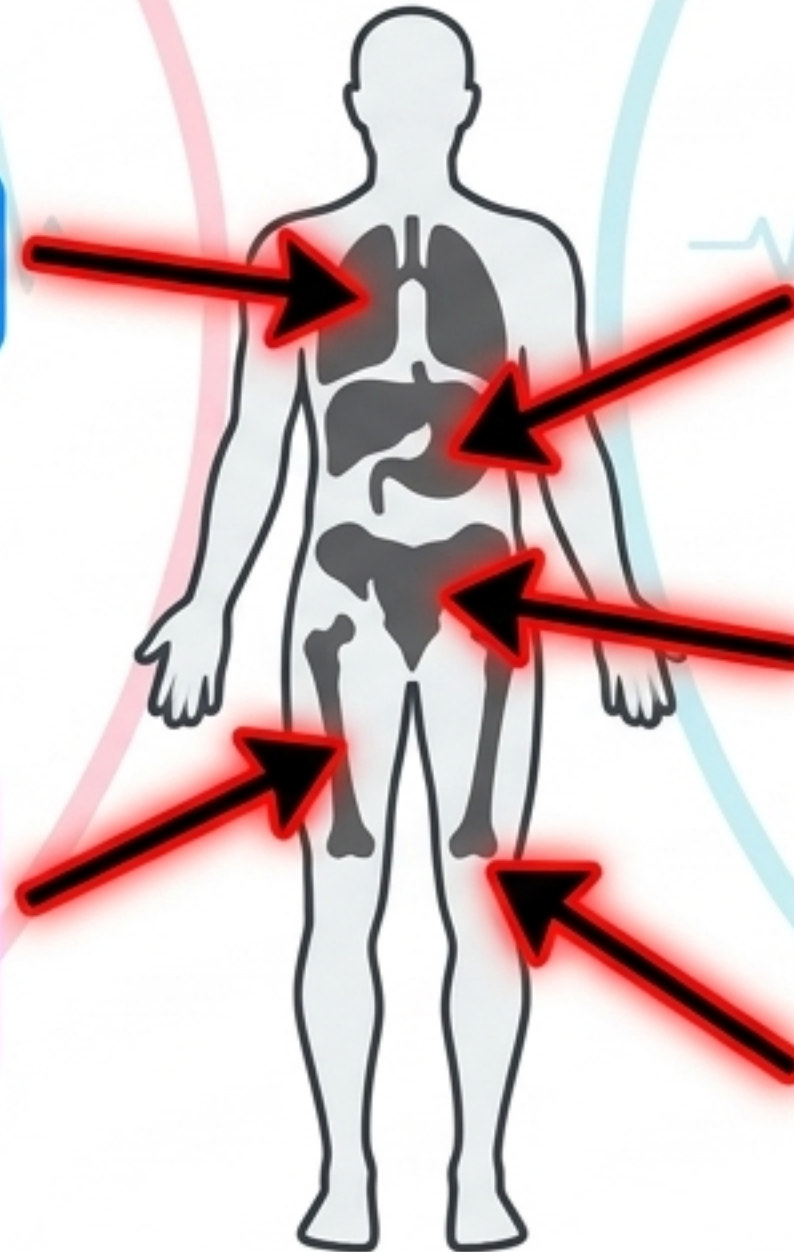
Espacio 1 - Tórax: Acumulación masiva en cavidad pleural (Hemotórax).

Espacio 2 - Abdomen: Lesión de órganos sólidos (hígado, bazo) o grandes vasos.

Espacio 3 - Pelvis y Retroperitoneo: Fracturas pélvicas desgarrando plexos venosos/arteriales (requiere compresión pélvica).

Espacio 4 - Huesos Largos: Fracturas bilaterales de fémur (pérdida de volumen significativa).

Espacio 5 - Externo: Heridas abiertas, amputaciones o lesiones vasculares periféricas.

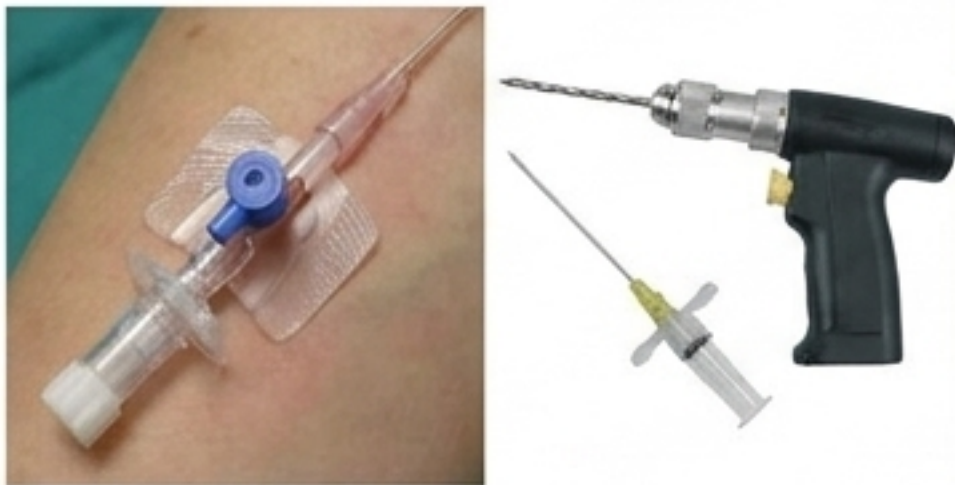


Reanimación Simultánea y Estrategia de Fluidos

Accesos Vasculares Rápidos

Obtener **2 vías venosas** periféricas de gran calibre.

Si hay fracaso o retraso → **Vía Intraósea inmediata** (permite líquidos, medicación y hemoderivados).



El Peligro de los Cristaloideos

Evitar administración indiscriminada. El exceso produce:

- ⚠ Hemodilución de componentes sanguíneos
- ⚠ Edema
- ⚠ Hipotermia
- ⚠ Empeoramiento de la coagulación

Transfusión y Hemoderivados

Uso **temprano** bajo protocolo de transfusión masiva.

Concentrado de Hematíes	Recupera capacidad de transporte de O ₂ .
Plasma	Aporta factores de coagulación.
Plaquetas	Formación del coágulo.

Evaluación Secundaria: Regla A.M.P.L.E. y Examen Físico

The AMPLE Rule

A

Alergias: Medicamentos, alimentos, látex, contrastes.

M

Medicamentos: Fármacos de uso habitual (¡Crítico identificar anticoagulantes!).

P

Pasado Médico: Enfermedades previas, cirugías, posibilidad de embarazo.

L

Libaciones (Última Comida): Hora de la última ingesta (riesgo de aspiración en cirugía/anestesia).

E

Eventos / Entorno: Mecanismo del trauma, uso de cinturón, pérdida de conciencia.

Examen Físico Sistemático



Cabeza/Cuello: Precaución cervical, pupilas.



Tórax: Inspección, palpación, percusión, auscultación.

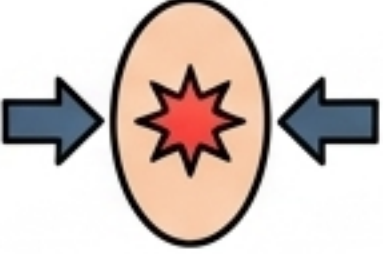
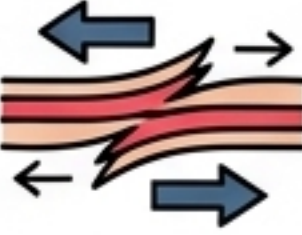


Abdomen/Pelvis: Distensión, equimosis, evitar manipulación pélvica innecesaria.

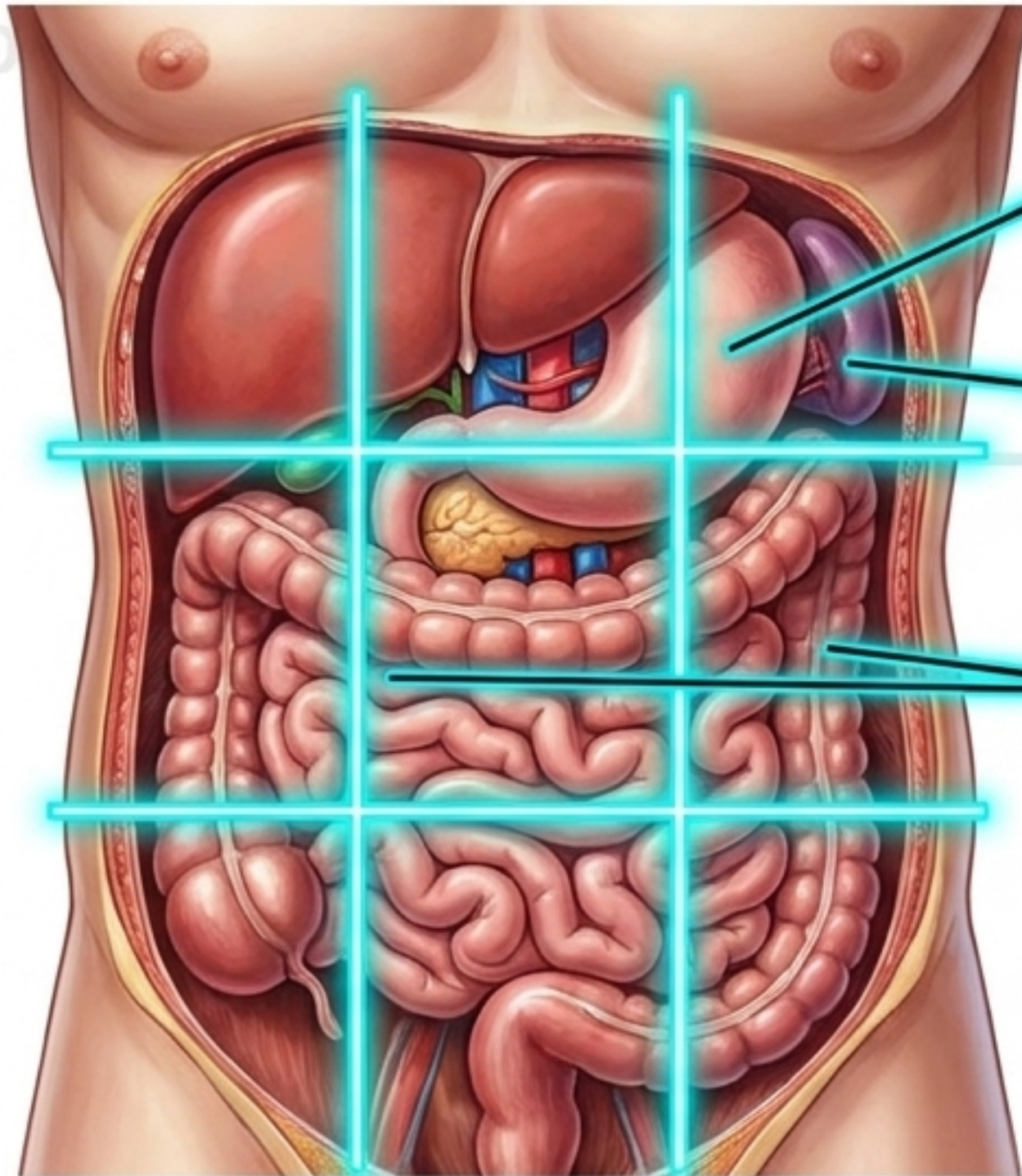


Extremidades: Pulsos, deformidades, estado neurológico.

Traumatismo Abdominal: Mecanismos de Lesión

Trauma Abdominal Cerrado (Sin solución de continuidad)	Trauma Abdominal Penetrante (Con solución de continuidad)
 Impacto Directo: Transmisión de energía produciendo contusiones o laceraciones.  Compresión: Aumento brusco de presión intraabdominal (ruptura visceral).  Desaceleración: Caídas/Accidentes. Los órganos se desplazan por inercia, generando tracción en pedículos vasculares.  Cizallamiento: Fuerzas en direcciones opuestas que separan tejidos/mesenterios.	 Arma Blanca: El daño depende de la trayectoria, profundidad y estructuras anatómicas atravesadas.  Arma de Fuego: Depende de trayectoria, pero se suma la velocidad, fragmentación y cavitación (energía transferida). Daño extenso más allá del trayecto directo.

Topografía Abdominal y Órganos de Alto Riesgo



Hipocondrio

Derecho:

Hígado, vesícula, duodeno.

Hipocondrio

Izquierdo:

Bazo, estómago.

Flancos:

Riñones, colon ascendente/ descendente.

Epidemiología Local (Trauma Cerrado)

Accidentes de tránsito (Causa Principal):

64.2%

Bazo:

41.1%

Hígado:

33.1%

Mesenterio: 15.9%

Trauma Penetrante

Afecta predominantemente **Hígado, Intestino Delgado, Colon y Estómago**, a menudo múltiples simultáneamente.

Trauma de Órganos Sólidos: Hígado, Bazo y Riñón (Escala AAST)

Clinica green

Violent medical red

1

2

3

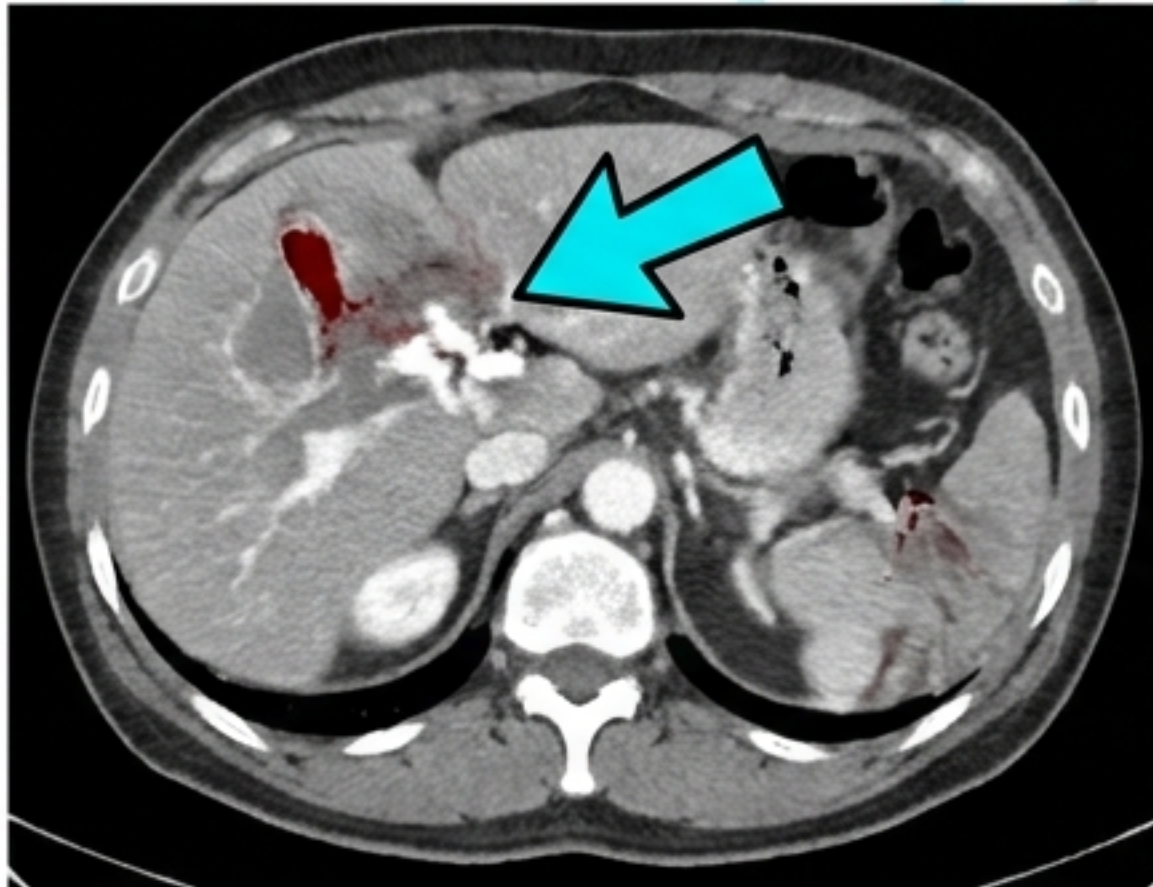
4

5

Grados I – II (Leve):
Contusiones, hematomas subcapsulares pequeños (<10-50%), laceraciones superficiales (<1-3 cm).

Grado III (Moderado):
Hematomas intraparenquimatosos (>5-10 cm), laceraciones profundas (>3 cm), extravasación urinaria ausente (riñón).

Grados IV – V (Severo):
Disrupción masiva del parénquima (25-75% de un lóbulo), sangrado activo, lesiones vasculares mayores del hilio, venas hepáticas, o riñón destrozado.



El Paradigma Quirúrgico

¡El grado anatómico por sí solo NO determina la cirugía! La conducta terapéutica depende principalmente de la ESTABILIDAD HEMODINÁMICA y la presencia de sangrado activo.



BADBEAR.MED

Diagnóstico por Imagen: FAST vs. Tomografía (TAC)

Ecografía FAST / eFAST



Indicación: Paciente hemodinámicamente **INESTABLE**.

Objetivo: Detectar líquido libre (hemoperitoneo) rápidamente a pie de cama. eFAST añade evaluación pulmonar (neumo/hemotórax).

Limitaciones: NO descarta lesión (puede ser negativo en sangrados retroperitoneales o poca cantidad de sangre). No identifica el órgano específico.

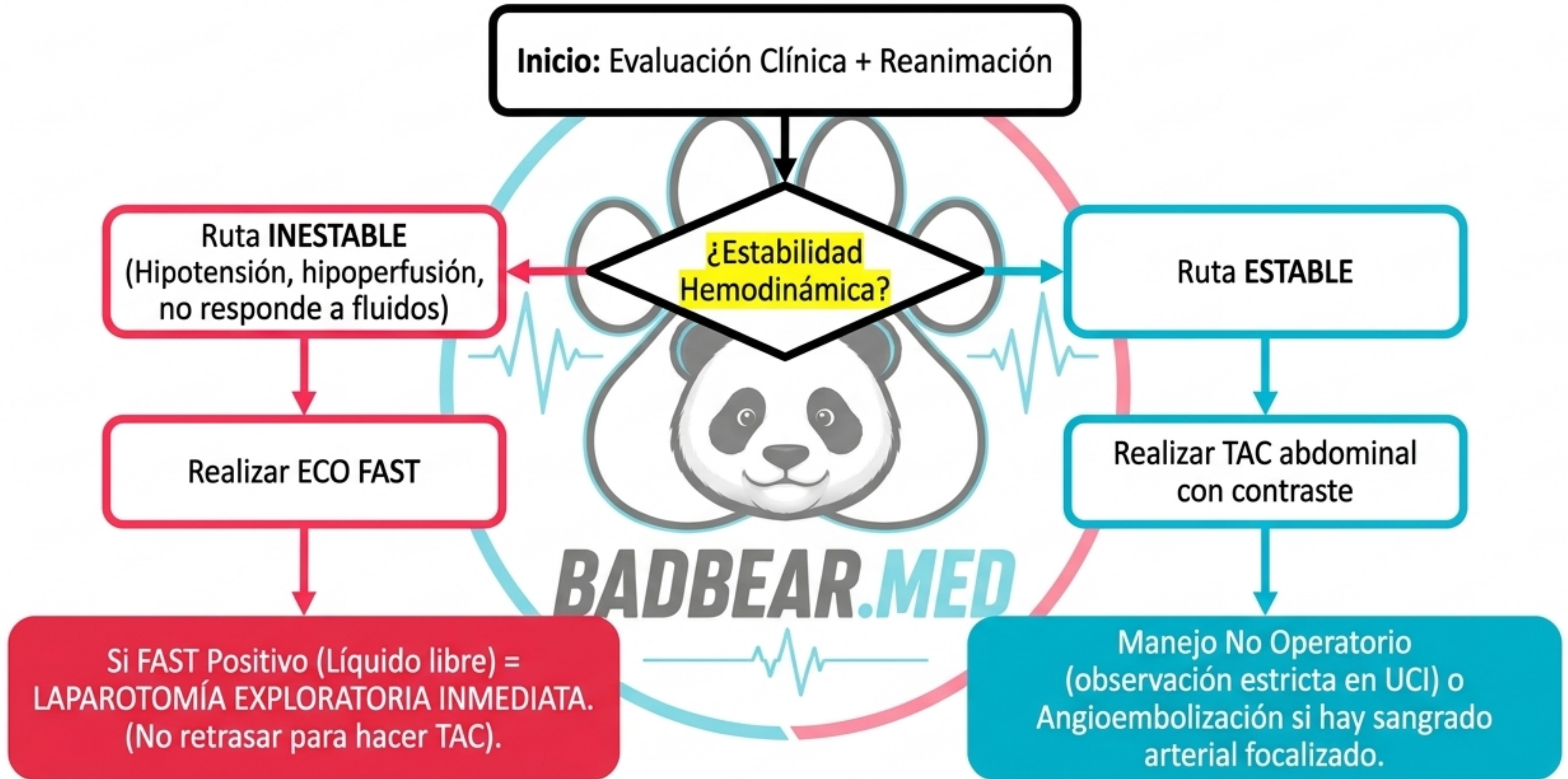
Tomografía Computarizada (TAC con contraste)



Indicación: Paciente hemodinámicamente **ESTABLE**.

Objetivo: Gold standard. Identifica el órgano exacto, extensión de la lesión (grado), y detecta sangrado activo (extravasación de contraste).

El Algoritmo Definitivo de Decisión Hemodinámica



Cirugía de Control de Daños (Damage Control)

Concepto: El objetivo inicial **NO** es reparar definitivamente las lesiones, sino controlar rápidamente la **hemorragia** y la **contaminación** para salvar la vida ante inestabilidad fisiológica profunda.

Fase 1: Cirugía Abreviada (Quirófano)

1

Control rápido de sangrado (empaquetamiento) y contaminación (ligaduras/grapado). Cierre abdominal temporal.



Fase 2: Reanimación (UCI)

2

Restaurar la fisiología. Corregir agresivamente la Tríada Mortal (calentamiento, reversión de acidosis y coagulopatía).

Fase 3: Reintervención Definitiva (Quirófano)

3

Una vez estabilizado (24-48h después), se retira el empaquetamiento y se realiza la reparación anatómica definitiva de los órganos y anastomosis.



Conclusiones y Reglas de Oro en Trauma

Regla 1: El protocolo X-A-B-C-D-E es dinámico y simultáneo. Evaluar y tratar las amenazas inminerientes al mismo tiempo.

Regla 2: En todo paciente traumatizado con shock, se asume que la causa es hemorrágica hasta demostrar lo contrario.

Regla 3: Un ECO FAST negativo NO descarta una lesión intraabdominal severa, especialmente si la clínica indica lo contrario.

Regla 4: La clínica manda. La decisión de operar un órgano sólido se basa en la ESTABILIDAD HEMODINÁMICA, no exclusivamente en el grado anatómico de la lesión.